

# CERMAM - AM - 2014

## Residência Médica - R1 - Prova 1

Prova com 100 questões

---

Nome: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

---

### Questão 1

A hiperglicemia crônica, comum ao Diabetes Mellitus tipos 1 e 2, responsável pelas complicações micro e macrovasculares e os consequentes desfechos desfavoráveis, pode ser menos deletéria quando o controle é baseado em metas. Assinale abaixo a meta para controle de adultos diabéticos da Hemoglobina A1C, (método HPLC = "High Performance Liquid Chromatography" ou CLAE = Cromatografia Líquida de Alta Eficiência) preconizada nas Diretrizes Brasileiras de Diabetes Mellitus (2012-2013).

- A) < 6%
- B) < 7%
- C) < 5%
- D) < 8%
- E) < 9%

### Questão 2

Das classes de drogas usadas no tratamento do diabetes mellitus do tipo 2, as que induzem a secreção de insulina somente na presença de glicose (glicose-dependente) são:

- A) Glitazona e Biguanidas.
- B) Análogos do GLP-1 e inibidores da DPP-4.
- C) Inibidor da Alfa-glucosidase e Sulfonilureias.
- D) Sulfonilureias e Gliptinas.
- E) Biguanidas e Análogos do GLP-1.

### Questão 3

Doença de Graves, a forma mais comum de hipertireoidismo, quando acomete mulheres grávidas apresenta características e cuidados específicos. Assinale abaixo a resposta INCORRETA:

- A) A crise tireotóxica, decorrente do hipertireoidismo na gravidez, exige cuidados intensivos devido à extrema gravidade.
- B) O Propranolol pode ser usado, porém em baixas doses e por um curto período de tempo, para evitar efeitos prolongados sobre o feto, como bradicardia ou retardo de crescimento intrauterino.
- C) Propiltiouracil não deve ser indicado para o tratamento no primeiro trimestre, devido ao risco de embriopatia acentuada.
- D) A administração de Iodo 131, como forma definitiva de tratamento do hipertireoidismo, é contraindicada durante a gravidez.
- E) hipertireoidismo materno não tratado pode causar prematuridade, baixo peso para a idade gestacional, retardo do crescimento intrauterino e aumento da morbimortalidade perinatal.

#### Questão 4

O descontrole crônico da hipertensão arterial sistêmica é a causa mais frequente de hemorragia intracerebral não traumática, também chamado de Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico (AVEH) principalmente em pessoas com menos de 55 anos e tabagistas. Marque a resposta ERRADA:

- A) As anormalidades neurológicas causadas pela hemorragia intracerebral não difere daquelas causadas por AVE Isquêmica (AVEI).
- B) A hemorragia pode crescer à medida que o sangramento continua, enquanto as lesões isquêmicas geralmente não mudam de tamanho depois da oclusão vascular.
- C) Nas hemorragias maciças no putâmen, os pacientes ficam letárgicos ou comatosos em minutos a horas depois do início e paresia contralateral com hernianopsia contralateral.
- D) Nas hemorragias pontinas graves os pacientes ficam comatosos, em geral com pupilas muito pequenas e não reativas.
- E) As hemorragias lobares, que são mais características na angiopatia amiloide do que na hipertensão arterial, são responsáveis por um terço das hemorragias intracerebrais.

#### Questão 5

Em relação à crise epiléptica, marque a alternativa INCORRETA:

- A) A Ressonância Nuclear Magnética (RNM) do cérebro complementa o estudo eletroencefalográfico, devendo ser realizada em todos os pacientes maiores de 18 anos de idade com suspeita de epilepsia.
- B) Na investigação das crises, a punção lombar é mandatória se houver suspeita de meningite ou encefalite.
- C) As drogas empregadas no tratamento da Epilepsia podem levar à osteopenia ou à osteomalácia, e com isso, aumentar o risco de fraturas ósseas.
- D) História prévia de neoplasia de mama pode sugerir necessidades de estudo de imagem cerebral, pelo risco aumentado de metástases servirem de focos convulsivos.
- E) No tratamento das crises, a falta de resposta a uma determinada droga anticonvulsivante, como a carbamazepina ou a fenitoína, impede a resposta à outra droga, sendo recomendadas outras formas de tratamento.

#### Questão 6

Homem, 43 anos, alcoolista crônico foi encontrado com rebaixamento do estado de consciência e levado ao Pronto-Socorro pelo Resgate. Ainda na ambulância, recebeu 50 ml de glicose a 50% endovenoso, com melhora do quadro, persistindo alguma confusão. Como se encontrava febril, foi necessário internação para investigação melhor do quadro. No dia seguinte, o paciente agravou o estado de confusão mental, agora com nistagmo multidirecional, paralisia do VI par craniano à esquerda e ataxia cerebelar. Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Provável quadro de hematoma subdural crônico.
- B) O quadro pode ter agravado por se tratar de Meningite bacteriana.
- C) O agravo se deve à Síndrome de Wernicke, decorrente da deficiência de tiamina.
- D) É quadro típico de demência alcoólica.
- E) A causa do agravo pode ser devida à mielinólise pontina central.

### Questão 7

Os tumores cerebrais podem se manifestar clinicamente através de sintomas generalizados que refletem a hipertensão intracraniana ou por sintomas localizatórios, que refletem a localização do tumor. Em relação às manifestações clínicas e a localização específica, ligue as colunas A e B corretamente. (VER IMAGEM)

- A) A-4; B-5; C-2; D -1; E-6; F-3.
- B) A-4; B-3; C-1; D-6; E-2; F-5.
- C) A-2; B-5; C-2; D- 6; E-3; F-1.
- D) A-3; B-4; C-5; D-1; E-2; F-6.
- E) A-4; B-6; C-2; D-1; E-5; F-3.

### Questão 8

Nas infecções do trato urinário adquiridas na comunidade, o agente etiológico mais comum é:

- A) Escherichia coli.
- B) Staphylococcus aureus.
- C) Klebsiella sp.
- D) Staphylococcus epidemidis.
- E) Proteus sp.

### Questão 9

Entre os achados abaixo, qual é o menos esperado na evolução da glomerulonefrite difusa aguda (GNDA ou glomerulonefrite pós-infecciosa)?

- A) Edema.
- B) Proteinúria maior que 3,5 g/24h.
- C) Hipertensão arterial.
- D) Hemácias dismórficas na urina.
- E) Oligúria.

### Questão 10

Uma paciente de 60 anos com 50 kg de peso tem diabetes melito tipo 2 há 16 anos. Evoluiu de microalbuminúria, há quatro anos, para uma proteinúria de 5,3 g/24H nos últimos dois anos. Considerando que sua creatinina é de 2,0 mg/dl, em qual estágio de doença renal crônica ela se encontra?

- A) Estágio 1
- B) Estágio 2
- C) Estágio 3
- D) Estágio 4
- E) Estágio 5

### Questão 11

Correlacione as alterações estruturais das glomerulonefrites com o quadro clínico e, em seguida, assinale a alternativa correta: I. Proteinúria nefrótica (> 3,5 g/24h), hipoalbuminemia, edema e dislipidemia; II. Insuficiência renal aguda, oligúria, hipertensão, edema, hematúria e proteinúria; III. Proteinúria, hematúria com declínio da taxa de filtração glomerular, hipertensão com proliferação das células e da matriz mesangial; IV. Proteinúria não nefrótica, insuficiência renal crônica e fibrose intersticial glomerular. ( ) GN proliferativa difusa (nefrite lúpica). ( ) Esclerose global (nefropatia diabética). ( ) GN membranosa (idiopática). ( ) GN mesangioproliferativa (nefropatia por IGA).

- A) II; IV; III; I.
- B) III; I; II; IV.
- C) I; II; III; IV.
- D) II; IV; I; III.
- E) II; III; I; IV.

### Questão 12

Homem de 58 anos vem apresentando nos últimos cinco dias, quadro de erisipela em M.I.E, febre, anorexia e evoluindo com redução ao volume urinário. Ao exame físico, paciente orientado, desidratado ++/4, hipocorado ++/4, FR = 32 (PM, temperatura axilar = 38,2°C, FC = 108 bpm, PA = 90 x 60 mmHg, ritmo cardíaco regular em 2T, e resultados dos exames complementares: Ht=26% Hb+ 10 g/dl, leucócitos = 14.000/mm<sup>3</sup> (15% bastões) glicose = 120 mg/dl ureia= 86 mg/dl creatina = 1,4 mg/dl, Na = 134 mEq/L, K= 5,3 mEq/L, pH = 7,28, PO2= 92 mmHg. PCO2 = 29 mmHg BE= - 8,3 HCO= 14 mEq/L. A medida clínica inicial mais apropriada é:

- A) Noradrenalina em doses elevadas.
- B) Hidratação venosa vigorosa, baseada na pressão venosa central e sinais vitais.
- C) Hemotransfusão para corrigir hemoglobina para 12%.
- D) Correção da acidose com bicarbonato de sódio endovenoso.
- E) Intubação orotraqueal e suporte ventilatório.

### Questão 13

Escolha a melhor droga ou combinação de drogas indicada no controle da hipertensão em vigência da dissecação de aorta:

- A) Furosemida + betabloqueador.
- B) Nitropussiato de sódio + betabloqueador.
- C) Nitropussiato de sódio isoladamente.
- D) Betabloqueador isoladamente.
- E) Nitropussiato de sódio + nifedipina.

#### Questão 14

Para cada série de parâmetros hemodinâmicos abaixo existe uma correspondência etiológica de choque. Assinale a alternativa que contempla as associações corretas (VER IMAGEM) A- Embolia pulmonar aguda maciça; B- Choque cardiogênico; C- Tamponamento cardíaco; D- Sepsis grave; E- Hemorragia digestiva aguda.

- A) I-D; II-B; III-A; IV-C; V-E
- B) I-B; II-C; III-A; IV-E; V-D
- C) I-D; II-B; III-C; IV-A; V-E
- D) I-C; II-A; III-B; IV-E; V-D
- E) I-D; II-B; III-E; IV-C; V-A

#### Questão 15

Correlacione os quadros clínicos dos pacientes abaixo com as doenças do quadro seguinte, assinalando a resposta certa da correspondência: I. M.S.F., homem, 57 anos, etilista pesado, hipertenso e diabético... (ver quadro clínico completo); II. A.M.S., Homem, 71 anos, tabagista pesado, etilista e hipertenso, com pleura facial...; III. F.C.A., mulher, 54 anos, tabagista, com turgência jugular e BRD...; IV. R.G.L., mulher, 70 anos, diabética, hipertensa, obesa, com onda Q em parede anterior. 1. Miocardiopatia dilatada provavelmente de etiologia chagásica. 2. Miocardiopatia isquêmica. 3. Miocardiopatia dilatada provavelmente de etiologia alcoólica. 4. Cor pulmonale.

- A) I-1, II-3, III-2, IV-4.
- B) I-3, II-2, III-4, IV-1.
- C) I-3, II-2, III-1, IV-4.
- D) I-3, II-4, III-1, IV-2.
- E) I-1, II-4, III-3, IV-2.

#### Questão 16

Homem, 51 anos, alcoolista, interna com quadro clínico-laboratorial de pancreatite aguda. É submetido a tratamento adequado e reavaliado após as primeiras 48 horas. Qual dos seguintes achados, se detectado neste período, é indicativo de mau prognóstico?

- A) Glicemia de 180 mg/dL.
- B) Leucócitos de 15500/mm<sup>3</sup>.
- C) Aumento do nitrogênio ureico em 7 mg/dL.
- D) PO<sub>2</sub> arterial de 65 mmHg.
- E) Estimativa de sequestro de fluídos em 5 litros.

#### Questão 17

Numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda, correlacionando as doenças sexualmente transmissíveis as suas técnicas diagnósticas 1. Clamídia; 2. Cancro mole; 3. Donovanose; 4. Gonorreia; 5. HPV ( ) O diagnóstico das lesões vegetantes é clínico... DNA viral por hibridização molecular. ( ) Bacterioscopia da secreção uretral pelo Gram: diplococos Gram-negativos... meio Thayer-Martin. ( ) Diagnóstico baseado na biópsia da lesão... afastar neoplasia. ( ) Bacterioscopia da secreção uretral por Gram não tem boa sensibilidade... ( ) Bacterioscopia com pesquisa do *Haemophilus ducreyi* é pilar diagnóstico. Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- A) 2 - 4 - 5 - 1 - 3
- B) 3 - 5 - 2 - 1 - 4
- C) 4 - 5 - 3 - 2 - 1
- D) 5 - 3 - 4 - 2 - 1

E) 5 - 4 - 3 - 1 - 2

### Questão 18

Paciente do sexo F. 23 anos, queixa-se de astenia, inapetência e febre vespertina há 3 semanas. Procurou PS devido dor torácica em base direita ventilatório dependente. Radiografia de tórax evidenciou velamento do seio costofrênico direito, sendo encaminhado ao ambulatório de Pneumologia para investigação do Derrame Pleural. Teve contato com o pai tuberculose há 2 anos. Qual a sua conduta com relação a propedêutica de investigação no caso acima?

- A) Solicitar TT (PPD), pesquisa do BAAR no escarro e iniciar esquema básico.
- B) Solicitar biópsia de pleura e iniciar esquema básico.
- C) Pesquisa de BAAR no líquido sinovial, sendo esta negativa, não deve ser tuberculose e não fica indicado tratamento.
- D) Toracocentese diagnóstica, se análise do líquido pleural revelar linfocitose = 75%, ADA = 45 U/l e DHL = 200 U/l, configurando-se exsudato, deve-se iniciar esquema básico.
- E) Iniciar tratamento com claritromicina.

### Questão 19

Um paciente HIV positivo (2 ELISA e 1 Western Blot positivos), com CD4 de 40 céls/mm<sup>3</sup>, é admitido por crise convulsiva. Ao exame de Tomografia (TC) de crânio contrastada, não evidenciou anormalidades e estudo líquórico mostrou 5 céls/mm<sup>3</sup>, com glicorraquia normal. A melhor condução para o caso é:

- A) Estudo do líquor com tinta Nankin e detecção de antígeno criptocócico.
- B) Biópsia cerebral estereotáxica.
- C) Iniciar carbamazepina.
- D) Fundoscopia.
- E) EEG.

### Questão 20

Homem, 52 anos, apresenta sinais de artrite aguda intensa na 1ª metatarsofalangeana direita. Esta é a 3ª crise nos últimos 6 meses. Tem diagnóstico de HAS, mas não faz tratamento, PA = 170/110 mmHg. Quais as medicações a serem prescritas nesse momento?

- A) Alopurinol, colchicina e losartana.
- B) Diclofenaco de sódio, prednisona e hidroclorotiazida.
- C) Butazolidina, prednisona e propranolol.
- D) Colchicina, alopurinol e propranolol.
- E) Anti-inflamatório não hormonal, colchicina e losartana.

### Questão 21

Paciente do sexo masculino, 38 anos, vítima de engavetamento (motorista, não usava cinto), conduzido ao PS. Apresenta-se comatoso, sem movimentos respiratórios e manobras de retificação de via aérea não surtem efeito. Sem desvio traqueal. SatO<sub>2</sub> 74%. Tórax com escoriação extensa toracoabdominal esquerda, crepitação à palpação, murmúrio vesicular diminuído à esquerda. Pulso fino, FC 110 bpm, PA 90x60. Contusão craniana frontal. Responde a estímulo doloroso com flexão, não abre os olhos, emite sons ininteligíveis. Midríase à esquerda. Abdome flácido. Bacia estável. Aumento de volume da coxa esquerda. Assinale a alternativa incorreta:

- A) Podemos afirmar que a intubação orotraqueal é a primeira prioridade no tratamento deste paciente e o colar cervical é obrigatório.
- B) Não há necessidade de radiografia prévia para que seja realizada drenagem fechada de tórax à esquerda.
- C) Devido ao TCE grave, o paciente deve ser submetido à tomografia de crânio logo após a drenagem de tórax.
- D) Podemos afirmar que o paciente acima perdeu cerca de 1.500ml de sangue, parcialmente justificada pela provável fratura de fêmur esquerdo.
- E) O exame físico do abdome deste paciente não é confiável, estando indicado FAST para avaliar possível hemorragia intra-abdominal.

### Questão 22

Paciente do sexo masculino, 42 anos, pedreiro, dá entrada no PS apresentando dor intensa em região inguinal direita após esforço físico excessivo, há 2 horas. Nega vômitos e parada de eliminação de flatos. Ao exame evidenciou-se hérnia inguinal encarcerada, sem sinais flogísticos, bastante dolorosa à palpação, impedindo sua redução. Assinale a alternativa que contempla a conduta mais adequada para o caso:

- A) Analgesia e alta hospitalar para que o paciente seja submetido a herniorrafia eletiva.
- B) Herniorrafia inguinal urgente via laparoscópica.
- C) Internação e aguardar redução espontânea pelo período de 12 horas.
- D) Analgesia potente e nova tentativa de redução.
- E) Deixar o paciente em jejum e descompressão gástrica e retal com sondas.

### Questão 23

Paciente do sexo feminino, 48 anos, refere quadro de dor epigástrica e mesogástrica, tipo queimação, de início súbito e bastante intensa, que migrou para todo o abdome em poucas horas. Refere quadro crônico de epigastralgia em queimação de 2 anos. Após 10 horas do início, apresentava-se imóvel na maca, com respiração rápida e superficial. Abdome plano, difusamente doloroso à palpação superficial, com descompressão brusca dolorosa nos quatro quadrantes. Assinale a alternativa correta:

- A) A radiografia de tórax fecha o diagnóstico sindrômico e confirma tratamento cirúrgico sem diagnóstico etiológico exato no caso acima.
- B) Por tratar-se de apendicite perforada, o esquema antibiótico de escolha para o caso é Ceftriaxona e Metronidazol.
- C) O hemograma e a ultrassonografia de abdome são essenciais para a conduta do caso acima.
- D) A ausência de febre e vômitos sugere tratar-se de abdome agudo inflamatório de tratamento clínico.
- E) Por tratar-se de dor intensa de início súbito, o diagnóstico mais provável é a trombose mesentérica, estando indicada arteriografia de urgência.

### Questão 24

Paciente de sexo feminino, 25 anos, refere dor abdominal tipo cólica, iniciada em mesogástrio, que migrou para fossa ilíaca direita, associada a náuseas e 1 episódio de febre baixa, há 24 horas. Abdome plano, flácido, doloroso à palpação profunda em ponto de McBurney. Sinal de Blumberg positivo. Qual o próximo passo na conduta desta paciente?

- A) Hemograma, exame de urina e radiografias de abdome.
- B) Ultrassonografia.
- C) Laparoscopia.
- D) Tomografia de abdome.
- E) Internação, antibióticos e observação por 24 horas.

### Questão 25

Paciente do sexo feminino, 62 anos, apresenta quadro de dor abdominal tipo cólica, de moderada intensidade, em fossa ilíaca esquerda, associada a náuseas e febre baixa, há 24 horas. Refere constipação crônica e episódios anteriores de menor intensidade. Nega sangramento à defecação. Abdome plano, flácido, doloroso à palpação profunda em fossa ilíaca esquerda. Descompressão brusca positiva em fossa ilíaca esquerda. Sem massas ou plastrão. Assinale a alternativa correta:

- A) A colonoscopia é o exame padrão-ouro para diagnosticar o caso acima.
- B) Já que há sinal de irritação peritoneal, a única modalidade de tratamento é cirúrgica.
- C) Já que não há história de hemorragia digestiva baixa, podemos afirmar que a constipação não faz parte da gênese da patologia da paciente acima.
- D) Por tratar-se de quadro meramente inflamatório, não há indicação de antibioticoterapia no caso acima.
- E) A tomografia de abdome pode dar o diagnóstico e direcionar a escolha entre tratamento clínico ou cirúrgico.

### Questão 26

Paciente do sexo masculino, 45 anos, deu entrada no PS há 1 semana com dor tipo cólica intensa em Hipocôndrio Direito (HD), náuseas e vômitos após refeição rica em gordura. Sinal de Murphy positivo, plastrão no HD, ausência de icterícia, internado e iniciado tratamento clínico. Evoluiu insatisfatoriamente, mas no 6º DIH apresentou melhora. No 7º DIH apresentou distensão abdominal progressiva, vômitos, cólica difusa e intensa, parada de eliminação de gases e fezes. Sem febre ou icterícia. RHA aumentados. Assinale a alternativa correta:

- A) O paciente apresenta provável pancreatite aguda como complicação do quadro, por migração do cálculo para o colédoco, confirmada pela verificação de hiperamilasemia.
- B) A presença de aerobilia na radiografia simples de abdome fecha o diagnóstico da complicação descrita acima.
- C) O paciente apresenta provável peritonite difusa estando indicada a sua transferência para a UTI para compensação clínica imediata antes da laparotomia exploradora.
- D) Os dados acima nos permitem afirmar que o paciente apresentou complicação do quadro por apresentar colecistite aguda por microcálculos.
- E) Há clara indicação de colecistectomia de urgência e antibioticoterapia.



### Questão 27

A Pancreatite grave é considerada patologia de altas taxas de morbimortalidade devido aos fatores abaixo, exceto:

- A) Evolução para insuficiência respiratória secundária a choque hipovolêmico e síndrome da resposta inflamatória sistêmica.
- B) Possível evolução para fascíte necrotizante de parede abdominal, evidente pelos sinais de Cullen e Gray-Turner.
- C) Necrose retroperitoneal por extravasamento de enzimas pancreáticas com possível evolução para abscesso.
- D) Níveis de amilase bastante elevados e de difícil controle clínico.
- E) Grande mobilização de líquido para o retroperitônio evoluindo como choque grave e insuficiência renal aguda.

### Questão 28

Paciente do sexo masculino, 55 anos, dá entrada por hematêmese severa e choque hipovolêmico. Ictérico +/4, emagrecido, pálido, taquicárdico, taquipneico, nível de consciência rebaixado e hipotenso. Abdome ascítico indolor. Esplenomegalia presente. Edema de MMII ++/4. Uso abusivo crônico de álcool. Não sabe informar história de hepatite prévia. Qual das opções de tratamento abaixo representa a de maior índice de letalidade para o caso acima?

- A) Octreotide endovenoso.
- B) Balão de Sengstaken-Blakemore.
- C) Tratamento endoscópico.
- D) TIPS.
- E) Controle cirúrgico do sangramento.

### Questão 29

Paciente com 75 anos, hipertenso, diabético, com sequela de AVC e IAM com menos de 6 meses. Apresenta câncer de cabeça de pâncreas, Estadiamento clínico (Ec) T1N0M0, sem invasão de estruturas adjacentes. Responda a alternativa correta abaixo:

- A) Irressecável, encaminhado para neoadjuvância e reavaliação
- B) Inoperável, encaminhado para quimioterapia paliativa
- C) Inoperável, encaminhado para adjuvância
- D) Irressecável, encaminhado para quimioterapia paliativa
- E) Irressecável, encaminhado para adjuvância

### Questão 30

Paciente do sexo feminino vem ao consultório do cirurgião portando endoscopia digestiva alta com diagnóstico de processo mitótico ulceroinfiltrativo em pequena curvatura gástrica, sem confirmação histopatológica. Emagrecida, hipocorada ++/4, anictérica e normotensa. Linfonodo palpável supraclavicular esquerdo. Abdome plano, flácido, indolor. Sem massa epigástrica palpável, mas com discreta ascite à palpação. Toque retal normal. Assinale a alternativa incorreta:

- A) Espera-se que a biópsia da lesão revele adenocarcinoma gástrico
- B) Os dados clínicos acima nos permitem afirmar que se trata de neoplasia gástrica incurável, porém não há dados suficientes para avaliar sua ressecabilidade
- C) O toque retal normal exclui a possibilidade de tumoração de Krukenberg no caso acima
- D) A paciente acima pode evoluir com hemorragia digestiva alta ou abdome agudo perfurativo
- E) O próximo passo para estadiamento adequado deste paciente é a tomografia

### Questão 31

Paciente do sexo feminino, 46 anos, portadora de constipação intestinal crônica, refere que há 2 semanas vem apresentando dor à defecação, fezes endurecidas e presença de raios de sangue no papel higiênico durante sua higienização. Qual das alternativas abaixo confere a hipótese mais provável, seu método diagnóstico e opção terapêutica?

- A) Hemorroidas internas grau II; exame proctológico; ligadura elástica.
- B) Fissura anal; inspeção proctológica; creme à base de diltiazem.
- C) Fístula perianal; exame proctológico; fistulotomia.
- D) Neoplasia de reto; retossigmoidoscopia com biópsia; retossigmoidectomia.
- E) Doença de Crohn; colonoscopia; prednisona oral.

### Questão 32

Qual dos fenômenos abaixo não está relacionado à resposta endócrina à hipovolemia?

- A) Liberação de noradrenalina pela suprarrenal.
- B) Reabsorção de água e sódio nos túbulos renais distais.
- C) Tentativa de compensação do débito cardíaco.
- D) Hipofluxo na arteríola aferente do glomérulo.
- E) Distensão dos barorreceptores carotídeos.

### Questão 33

Paciente do sexo masculino vem ao pronto atendimento queixando dor abdominal intensa, tipo cólica, de início súbito, em flanco direito e fossa ilíaca direita, irradiada para a hemibolsa testicular direita. Não há sinais de irritação peritoneal. O exame de urina (EAS) revela hematúria microscópica, porém a USG abdominal não revelou alterações. Qual o próximo passo na investigação deste paciente e sua provável abordagem terapêutica?

- A) Tomografia computadorizada helicoidal; ureterolitotripsia endoscópica.
- B) Tomografia computadorizada; nefrectomia direita videolaparoscópica.
- C) Cistoscopia; antibioticoterapia.
- D) Urografia excretora; nefrectomia aberta.
- E) Radiografia simples de abdome; hidratação venosa e antiespasmódicos.

### Questão 34

A cirurgia laparoscópica é considerada a maior revolução em técnica cirúrgica nos últimos decênios. Sobre essa nova abordagem cirúrgica dos pacientes, assinale a alternativa incorreta:

- A) Apesar das indicações cada vez mais abrangentes da laparoscopia no tratamento de patologias abdominais, esta é limitada nos casos de urgência pela frequente instabilidade hemodinâmica destes pacientes.
- B) A laparoscopia pode ser realizada durante a gravidez com mínima morbidade para o feto e para a mãe.
- C) Há maior incidência de hérnia incisional quando comparada à laparotomia (cirurgia aberta), devido ao aumento da pressão intra-abdominal pelo pneumoperitônio.
- D) Dentre suas vantagens, podemos destacar o menor trauma cirúrgico, menor dor no pós-operatório e menor incidência de aderências intra-abdominais.
- E) O pneumoperitônio realizado na laparoscopia pode reduzir o retorno venoso por aumento da pressão intra-abdominal, além de arritmias e bradicardia, limitando seu uso em pacientes cardiopatas.

### Questão 35

Paciente do sexo masculino, 6 anos, apresenta quadro de massa cervical, de consistência cística, de cerca de 2cm, localizada anteriormente, na linha média a nível de osso hióide, com evolução de 2 anos, inclusive evoluindo com abscedação em 2 ocasiões. Qual a hipótese diagnóstica mais provável?

- A) Cisto tireoglosso.
- B) Cisto branquial.
- C) Cisto tireoidiano congênito.
- D) Neoplasia cística de glândula salivar sublingual.
- E) Linfonodomegalia.

### Questão 36

Paciente de sexo masculino, 58 anos, hipertenso, diabético, tem indicação de colectomia esquerda eletiva por neoplasia de cólon. Faz uso domiciliar de metformina, losartana e AAS diariamente. Referente ao seu preparo pré-operatório, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) O AAS deve ser suspenso 1 semana antes do procedimento devido a sua ação antiplaquetária.
- B) O anti-hipertensivo não deve ser suspenso, devendo ser administrado via oral até mesmo no dia do procedimento cirúrgico.
- C) Será mantido o hipoglicemiante oral durante a internação assim como dieta hipocalórica, podendo ser administrada insulina subcutânea caso não haja controle glicêmico satisfatório.
- D) Há indicação de verificação da glicemia capilar a cada 6 horas durante o período de internação.
- E) O paciente deve internar preferencialmente 1 dia antes do procedimento cirúrgico para ser submetido a preparo de cólon.

### Questão 37

Paciente vítima de ferimento de arma de fogo em tórax, apresenta quadro de dispneia intensa (FR 30 irpm), agitação psicomotora e dor torácica. Hipocorado +/-4, taquicárdico e hipotenso. Desvio da traqueia para a direita e turgência jugular. Ausculta cardíaca normal. Murmúrio vesicular abolido à esquerda. Hipertimpanismo à percussão do hemitórax esquerdo. Assinale a alternativa correta:

- A) A tríade de Beck descrita acima fecha o diagnóstico de tamponamento cardíaco estando indicada a toracotomia de emergência.
- B) A turgência jugular pode ser justificada por deslocamento do mediastino ocasionada por hérnia diafragmática traumática.
- C) Não há necessidade de radiografia de tórax para o tratamento da lesão acima.
- D) Os sinais de choque descritos fecham o diagnóstico de hemotórax maciço estando indicada a toracotomia de urgência.
- E) O pneumotórax simples descrito acima não justifica os sinais de choque hipovolêmico, estando indicada a investigação de outro sítios de sangramento.

### Questão 38

Neonato, 1 mês de idade, nascido de parto domiciliar, é trazido ao pediatra devido à mãe observar dispneia e "palpitação". Em bom estado geral, acianótico, normocorado e eutrófico. Desdobramento de segunda bulha e sopro sistólico em foco aórtico. Ecocardiograma com Doppler confirmou Comunicação Interatrial (CIA). Assinale a alternativa incorreta:

- A) Haverá evolução para insuficiência cardíaca grave com cianose e alta mortalidade até o primeiro ano de vida, mesmo com tratamento cirúrgico.
- B) É a cardiopatia congênita mais frequente e usualmente assintomática.
- C) O principal distúrbio hemodinâmico é a sobrecarga de volume do ventrículo direito com hiperfluxo pulmonar.
- D) O fechamento espontâneo da CIA é raro e o uso de diuréticos pode melhorar os sintomas.
- E) A correção endovascular da CIA ou a atrioseptoplastia com circulação extracorpórea são opções terapêuticas para o caso.

### Questão 39

Quais são as células mais importantes durante as fases principais da cicatrização de feridas?

- A) Neutrófilos, plaquetas, fibroblastos e hepatócitos.
- B) Plaquetas, neutrófilos, queratinócitos e neurônios.
- C) Plaquetas, macrófagos, fibroblastos e queratinócitos.
- D) Macrófagos, miofibroblastos, plaquetas e hepatócitos.
- E) Hemácia, macrófagos, plaquetas e histiócito.

### Questão 40

Paciente do gênero masculino com 65 anos de idade e peso corporal de 70 kg, sofre queimadura de 2º grau, superficial e profunda, acometendo 30% de superfície corporal. O acidente ocorreu em nível domiciliar com água fervendo a mais ou menos 5h. Qual o volume total de líquidos que devemos administrar nas primeiras 24h?

- A) 4200 ml.
- B) 8400 ml.
- C) 5200 ml.
- D) 2500 ml.
- E) 12000 ml.

### Questão 41

Quando o FSH se liga à célula da granulosa, estimula a ação de uma enzima que converte os androgênios em estradiol e estrona, qual o nome desta enzima?

- A) Metiltransferase
- B) Aromatase
- C) Cicloxygenase
- D) Hidroxilase
- E) Redutase

#### Questão 42

Paciente 23 anos, foi ao ginecologista com queixa de dismenorreia intensa acompanhada de cefaleia e náuseas que se iniciaram logo após a menarca. Os exames físico, ginecológico e laboratoriais foram normais. Tendo sido feito o diagnóstico de dismenorreia primária, qual o melhor tratamento pra essa paciente?

- A) Inibidores da Prostaglandina
- B) Antiespasmódicos de ação central
- C) Inibidores de ocitocina
- D) Inibidores do eixo hipotálamo hipófise ovário
- E) Inibidores da ECA

#### Questão 43

Paciente 17 anos procura ginecologista devido à secreção vaginal intermitente, há alguns anos, nega odor e prurido, mantém atividade sexual regular e refere uso de preservativo irregularmente. Ao exame especular observa-se secreção branca em pequena quantidade, teste de Wiff negativo e pH = 4,5. Ao exame microscópico observa-se leucócitos +/4+, presença de bacilos gram positivos e raros cocos gram positivos. A hipótese diagnóstica é:

- A) vaginite por monília
- B) vaginite citolítica
- C) conteúdo vaginal fisiológico
- D) vaginose bacteriana
- E) vaginose por HPV

#### Questão 44

Paciente 18 anos refere irregularidade menstrual com longos períodos de amenorreia. Ao exame clínico, observa-se hirsutismo e acne, sinais claros de hiperandrogenismo. Foi solicitada ultrassonografia que evidenciou ovários aumentados de volume com folículos atrésicos bilateralmente. Baseado no quadro assinale a resposta correta.

- A) Os atrasos menstruais e amenorreia são explicados pelos elevados níveis plasmáticos de progesterona e caracterizam a doença.
- B) O tratamento de primeira linha é feito com fármacos antiandrogênicos.
- C) O diagnóstico é feito apenas com o resultado da ultrassonografia.
- D) A prolactina também estará aumentada.
- E) Pode se associar a dificuldades para engravidar, mas a concepção pode acontecer mesmo sem o uso de indutores de ovulação.

#### Questão 45

Paciente 38 anos refere corrimento vaginal abundante, amarelo esverdeado, bolhoso e com odor fétido. O diagnóstico mais provável e a propedêutica prática para complementar o diagnóstico é:

- A) Tricomoníase - Exame a fresco;
- B) Vaginose Bacteriana - Colposcopia;
- C) Vaginose Bacteriana - Coloração pelo gram;
- D) Vaginose citolítica - Colprocitologia;
- E) Pseudomoníase - Coloração pelo gram.

**Questão 46**

Qual das infecções genitais abaixo é diagnosticada pelo teste de Tzanck:

- A) Sífilis;
- B) Vaginose Bacteriana;
- C) Clamídia;
- D) Gonorreia;
- E) Herpes genital.

**Questão 47**

Paciente 25 anos, G3P3Ab0, procura ambulatório de ginecologia com diagnóstico de lesão baixo grau (NIC1) à biopsia de colo. Usa anticoncepcional hormonal injetável e iniciou sua atividade sexual há 7 anos. Insiste com o médico que tem que tomar vacina contra papilomavírus humano (HPV), para tratar a doença. Em relação à indicação da vacina, é correto afirmar que:

- A) É indicada pois a vacina aumentará os níveis de anticorpos aumentando a probabilidade de regressão espontânea da lesão;
- B) Não há contraindicação formal para a sua administração, no entanto, a vacina não interferirá na evolução da lesão atual;
- C) É contraindicada, pois a vacina potencializará a ação do vírus, possibilitando a progressão da doença atual.
- D) É indicada, pois o fator de necrose do HPV induzido pela vacina atuará na imunidade da paciente fazendo a regressão induzida da lesão.
- E) É contraindicada, pois a paciente é sexualmente ativa há mais de 5 anos.

**Questão 48**

São estruturas que compreendem o diafragma pélvico:

- A) Ligamento cardinal e uterossacro
- B) Músculo bulbocavernoso e ileococcígeo
- C) Músculo transverso profundo e transverso superficial do períneo
- D) Músculo elevador do ânus e coccígeo
- E) Músculo puborretal e ligamento uterossacro

**Questão 49**

Paciente 35 anos procurou o ambulatório de infertilidade da UFAM. Refere nunca ter gestado e estar tentando engravidar há 3 anos. Foi solicitada a propedêutica e a única alteração foi a presença de um nódulo sólido miometrial intramural com componente submucoso. Foi solicitada histeroscopia diagnóstica, que observou a lesão abaulada na cavidade endometrial. Qual a melhor conduta a ser tomada:

- A) Aguardar a gestação espontânea por mais 6 meses
- B) Miomectomia
- C) Curetagem uterina
- D) Histerossalpingografia com biopsia para avaliar malignidade do nódulo
- E) Embolização seletiva da artéria ilíaca externa

### Questão 50

Paciente de 16 anos liga dia 20 de novembro para o seu ginecologista referindo que durante o ato sexual com seu namorado, o preservativo rompeu. Como estava muito preocupada, fez ducha vaginal. Refere que sua última menstruação foi dia 7 de novembro e que sua menstruação costuma vir a cada 28 dias. Ao telefone, qual seria a melhor orientação para a adolescente?

- A) A ducha vaginal foi medida eficiente para o coito realizado fora do período fértil.
- B) Tranquilizar a paciente pois ela não estava no período fértil.
- C) Prescrever acetato de medroxiprogesterona -150 mg/IM dose única.
- D) Prescrever noretindrona 0,35 mg, 12/12h, por 2 dias.
- E) Prescrever levonorgestrel 0,75 mg, 12/12 horas por 1 dia.

### Questão 51

Como denomina-se a ocupação dos fundos de saco laterais pelo útero gravídico a partir do terceiro mês de gestação:

- A) Puzos
- B) Osiander
- C) Paul Brunnel
- D) Nobile-Budin
- E) Hegar

### Questão 52

Paciente com atraso menstrual de 4 dias e com Bhcg de 800 mUI/ml, a ultrassonografia apresenta espessamento endometrial. O diagnóstico mais provável é:

- A) Abortamento
- B) Gestação incipiente
- C) Mola hidatiforme parcial
- D) Gestação ectópica
- E) Gestação gemelar

### Questão 53

Gestante manda Whatsapp para o obstetra no qual dizia que a última menstruação se iniciou no dia 25 de fevereiro de 2013 e gostaria de saber a data provável do seu parto. Baseando-se na regra de Nagele, o obstetra respondeu que a data provável seria:

- A) 04/12
- B) 01/12
- C) 28/11
- D) 18/12
- E) 08/11

#### Questão 54

Paciente em trabalho de parto acabou de ser examinada pelo residente de obstetrícia. Ao ser perguntado sobre qual plano o feto se encontrava respondeu: Naquele plano localizado ao nível das espinhas isquiáticas. Qual plano o residente se referia?

- A) Primeiro plano de De Lee e Plano zero de Hodge.
- B) Plano zero de De Lee e Segundo plano de Hodge.
- C) Terceiro plano de Hodge e terceiro plano de De Lee.
- D) Plano zero de De Lee e terceiro plano de Hodge.
- E) Segundo plano de De Lee e plano zero de Hodge.

#### Questão 55

Maria, 24 anos, G1 P0 está em trabalho de parto com o feto em apresentação cefálica fletida. Nessa paciente, quando poderemos dizer que já ocorreu a insinuação?

- A) Quando o diâmetro Biparietal ultrapassa o estreito médio.
- B) O vértice da apresentação atinge o plano das espinhas ciáticas.
- C) O ponto de maior declive da apresentação atinge o períneo.
- D) O maior diâmetro da cabeça atinge o plano zero de De Lee.
- E) Quando ocorrer o Hipomóclio.

#### Questão 56

Geisa, 26 anos, gestante de 39 semanas em franco trabalho de parto em monitorização contínua, apresentou desacelerações precoces tipo I. O que esse achado significa?

- A) Insuficiência placentária e hipóxia generalizada.
- B) Resposta centrovagal pela compressão do polo cefálico fetal.
- C) Hipóxia cerebral acentuada com dano cerebral irreversível.
- D) Compressão da placenta pelo feto com hipóxia.
- E) Compressão da placenta pelo feto sem indicar hipóxia.

#### Questão 57

Paciente 32 semanas de gestação chega à maternidade com PA: 180 x 130 mmHg e turvação visual. Na propedêutica laboratorial, além de dosagem de proteinúria de 24 horas, deverão ser solicitados no momento de sua internação:

- A) eletrólitos, bilirrubina, coagulograma, glicemia, fundo de olho e urinocultura.
- B) Transaminases, hemograma, fosfatase alcalina, urinocultura e colpocitologia.
- C) Provas de função renal, glicemia, fosfatase alcalina, hemograma completo, urinocultura.
- D) Hemograma, hematoscopia, provas de função hepática, coagulograma e urina tipo 1.
- E) Glicemia, provas de função renal, transaminases e fundo de olho, rotina de Kramer.



### Questão 58

Uma gestante de 30 anos, com 28 semanas de gestação, apresenta ao exame de rotina, glicemia de 162 mg/dl uma hora após a ingestão de dextrose. Qual a melhor conduta:

- A) Solicitar curva glicêmica.
- B) Instituir dieta e após 3 semanas solicitar perfil glicêmico.
- C) Iniciar hipoglicemiante oral
- D) Iniciar insulina usando a fórmula  $0,6 \times \text{peso}$  para calcular a dose total diária.
- E) Iniciar insulina usando a fórmula  $0,9 \times \text{peso}$  para calcular a dose total diária segundo White.

### Questão 59

Paciente múltipara, com 35 semanas de gestação é admitida na maternidade com história de perda líquida. Ao exame especular foi visualizada pequena quantidade de líquido em fundo de saco vaginal posterior. O achado complementar que melhor pode confirmar esse diagnóstico é:

- A) Centralização fetal
- B) pH vaginal abaixo de 6
- C) Leucocitose e desvio
- D) Cristalização arboriforme do muco cervical
- E) Ultrassonografia transvaginal

### Questão 60

Gestante 34 semanas foi levada à maternidade apresentando quadro de dor abdominal súbita e sangramento vaginal discreto iniciado há uma hora. Ao exame físico: agitada, sudoreica, PA 90x40mmHg, FC 130 bpm; contrações frequentes de pequena intensidade, tônus uterino aumentado. BCF 95 bpm. Ao toque: colo fechado com saída de pequena quantidade de sangue escurecido. Ao exame especular sangramento escurecido proveniente do orifício cervical externo. Qual a principal hipótese diagnóstica.

- A) Rotura uterina
- B) Placenta prévia total
- C) Placenta prévia marginal
- D) Início de trabalho de parto
- E) Descolamento prematuro da placenta.

### Questão 61

Ana de 3 anos chega ao Pronto-Socorro com história prévia de diarreia, inúmeras evacuações por dia, fezes de característica líquida. O preceptor diz para o residente que ela está com choque hipovolêmico, pois apresenta os seguintes sinais clínicos:

- A) Mucosa úmida, boa percussão e choro forte.
- B) Neurológico adequado, criança lúcida, orientada e extremidades quentes.
- C) Diurese clara e abundante, choro fraco, pele fria e eupneica.
- D) Alteração no estado mental (chorando pedindo mãe), eupneica, leve taquicardia e pulsos cheios.
- E) Alteração no estado mental (torporosa), taquipneia, extremidades frias, oligúria e hipotensão.

### Questão 62

MJN, 1 ano, chega no Pronto-Socorro com temperatura = 39.8°C, desvio da comissura labial, movimentos tônico-clônicos. Esta manifestação dura em torno de 5 min e responde à terapêutica. Contudo, durante a avaliação aguda, a responsabilidade mais importante do médico é determinar:

- A) A causa da febre e descartar meningite ou encefalite;
- B) A lesão cerebral causada pela convulsão
- C) O nível sérico adequado do benzodiazepínico
- D) A sorologia para HIV e CMV
- E) Se houve alteração no estado mental por meio de eletroencefalograma.

### Questão 63

Nos casos de acidose metabólica temos os tampões fisiológicos: tampões bicarbonato e não bicarbonato. Qual elemento abaixo participa dos tampões não bicarbonato?

- A) Sódio
- B) Lipídeos
- C) Fósforo
- D) Carboidrato
- E) Cálcio

### Questão 64

Lactente eutrófico, alimentado somente com leite materno, iniciou quadro de diarreia líquida há 03 dias, acompanhada de febre e vômitos. Evoluindo com taquipneia, oligúria, sonolência, com sinais de desidratação grave. Após etapa de expansão (3x), apresentou diurese em pequena quantidade. Exames: Na=115, K=1,5; Ca=0,9; Mg=2; Fósforo=4mg/dl. Com relação aos distúrbios hidroeletrólíticos devemos corrigir:

- A) O quadro de Hiponatremia e Hipopotassemia e ambos devem ser corrigidos, pois são considerados graves e com risco de vida.
- B) Não há distúrbios eletrolíticos para corrigir.
- C) O quadro de Hipofosfatemia e Hipomagnesemia e ambos devem ser corrigidos, pois são considerados graves e com risco de vida.
- D) Não há necessidade de correção da Hiponatremia.
- E) Os distúrbios em questão não são de natureza aguda não precisam de correção.

### Questão 65

Entende-se por ALIMENTOS COMPLEMENTARES:

- A) Conjunto de outros alimentos, além do leite materno oferecidos durante o período de aleitamento.
- B) Fórmulas artificiais.
- C) Conjunto de outros alimentos, além do leite artificial oferecidos durante o período do primeiro ano de vida.
- D) Conjunto de guloseimas, além do leite materno oferecidos durante o período de aleitamento.
- E) Aditivos do leite humano.

**Questão 66**

Duas mães aguardando o atendimento obstétrico conversam sobre a importância da alimentação saudável para a criança, a fim de prevenir obesidade e suas complicações. Diante do conceito programação metabólica (programming) devemos começar o estímulo à alimentação saudável desde a:

- A) Pós-menopausa;
- B) Gestação;
- C) Primeira Infância;
- D) Segunda infância;
- E) Lactente.

**Questão 67**

AMT, adolescente viajou para o Careiro e após 1 semana apresentou cefaleia intensa, febre, mialgia, artralgia (febre quebra-ossos) e após alguns dias começou exantema. O diagnóstico provável é:

- A) Sarampo
- B) Seps
- C) Dengue
- D) Rubéola
- E) Varicela

**Questão 68**

Segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS e Ministério da Saúde devemos estimular:

- A) Aleitamento materno exclusivo até 3 meses e total de 1 ano
- B) Aleitamento materno exclusivo até 8 meses e total 3 anos
- C) Aleitamento materno exclusivo até 6 meses e total de 1 ano
- D) Aleitamento materno exclusivo até 9 meses e total de 1 ano
- E) Aleitamento materno exclusivo até 6 meses e total de 2 anos

**Questão 69**

Ana Paula leva seu filho de 9 meses ao CAIC, relata que teve diarreia há 5 dias e agora está melhor. Na avaliação é constatado que a criança tem no cartão de vacina registro de 1 dose de BCG e 2 doses de hepatite B. Qual a melhor conduta:

- A) Tratar a diarreia e solicitar à mãe que volte em uma semana para atualizar vacinas.
- B) Aplicar uma dose de cada uma das vacinas, hepatite B, tetravalente bacteriana, poliovírus oral, rotavírus oral, febre amarela.
- C) Aplicar uma dose de cada uma das vacinas: hepatite B, tetravalente bacteriana, antipneumocócica, poliovírus oral e febre amarela.
- D) Aplicar somente vacinas de via parenteral e evitar as formulações orais.
- E) Não aplicar nenhuma vacina.

### Questão 70

Manuela, 7 anos, em consulta no pronto-socorro, com quadro de faringoamigdalite, adenomegalias cervicais e exantema micropapular em "lixa". Qual o provável diagnóstico?

- A) Escarlatina.
- B) Eritema infeccioso.
- C) Sarampo.
- D) Eritema Tóxico.
- E) Doença de Kawasaki.

### Questão 71

A menor A.L.M., 2 anos, foi atendida no PSC zona sul com história de 3 dias com diarreia e febre, porém mãe informa que todo mês ela tem diarreia. Moram em uma invasão na Zona Leste, água não tratada, lixão próximo. Recebeu Leite materno só até o 2º mês de vida. Atualmente recebe 4 mamadeiras de leite diluído (divide com 5 irmãos), 6 medidas de arrozina para 200 ml de água, não come frutas, carne, nem verduras. Ao exame: criança apática, hipocorada, dermatose generalizada, hiperemia perianal, edema periorbital e de membros inferiores, hepatomegalia, cabelo de duas cores (sinal da Bandeira). Qual o diagnóstico nutricional?

- A) Marasmo
- B) Kwashiorkor
- C) Deficiência exclusiva de Vitamina C
- D) Obesidade
- E) Deficiência exclusiva de zinco

### Questão 72

MST, masculino, 14 anos, apresenta palidez, anorexia, astenia e sonolência excessiva. Está crescendo muito rápido, segundo informa mãe. Qual diagnóstico mais provável?

- A) Giardíase
- B) Mononucleose
- C) Anemia ferropriva
- D) anemia megaloblástica
- E) depressão

### Questão 73

A.N.T., 8 meses foi levado por sua mãe ao Posto e durante exame o pediatra observou que o perímetro cefálico estava < - 3 escore Z e apresentava atraso de dois marcos de desenvolvimento. Qual impressão diagnóstica e conduta?

- A) Adequado Desenvolvimento. Acalmar a mãe.
- B) Atraso no desenvolvimento. Referir para avaliação neuropsicomotora.
- C) Adequado desenvolvimento. Não registrar na caderneta da criança.
- D) Atraso no desenvolvimento. Brigar com a mãe pela negligência.
- E) Atraso no desenvolvimento. Chamar o conselho tutelar.

#### Questão 74

MARIA de 35 dias é atendida no pronto-socorro com quadro de bronquiolite viral aguda. Mãe relata prematuridade de 35 semanas, AIG, não necessitando de cuidados ventilatórios. Exame físico regular estado geral, dispneica, FR: 82 irpm, sem tiragem ou batimento de aletas nasais, MV presente e diminuído universalmente, com sibilos esparsos. Exames: saturação de O<sub>2</sub> de 95% em repouso; radiografia de tórax: pulmões hiperinsuflados com reforço da trama broncovascular. O pediatra decide pela internação hospitalar. As alterações clínicas ou laboratoriais que determinaram essa decisão foram:

- A) radiografia do tórax e idade.
- B) estado geral e prematuridade.
- C) saturação de O<sub>2</sub> e prematuridade.
- D) idade e FR elevada.
- E) radiografia de tórax e saturação de O<sub>2</sub>.

#### Questão 75

Escolar de dez anos é levado ao pronto-socorro em crise de asma iniciada na noite anterior. A mãe relata tosse, chiado, dispneia e vômitos. Exame físico: lúcido, orientado, acianótico, tax 36,4° C, FR 40 irpm, FC: 112 bpm, SaO<sub>2</sub>: 94%, dispneia leve sem retrações intercostais e presença de sibilos expiratórios. O tratamento indicado neste momento é:

- A) Aminofilina intravenosa.
- B) Adrenalina subcutânea.
- C) corticosteroide via inalatória.
- D) Sulfato de magnésio intravenosa.
- E)  $\beta$ 2-agonistas de ação curta por via inalatória.

#### Questão 76

Quais os parasitas mais comumente envolvidos na espoliação do ferro na criança?

- A) Giardia lamblia e Necator americanus.
- B) Ancylostoma duodenale e Ascaris lumbricoides.
- C) Necator americanus e Ancylostoma duodenale.
- D) Giardia lamblia e Ascaris lumbricoides.
- E) Entamoeba coli e Ancylostoma duodenale.

#### Questão 77

Paciente 12 anos de idade, vem a consulta de Pediatria sem queixas, ao exame físico bom estado geral, genitália com presença de pelos finos, lisos, longos escuros na base do pênis, bolsa escrotal afinada e hipervascularizada, aumento do volume testicular sem aumento do tamanho do pênis. Em relação ao Estágio de Maturação Sexual de Tanner, responda:

- A) Paciente está em Tanner G3P3
- B) Paciente está em Tanner G2P3
- C) Paciente está em Tanner M1P2
- D) Paciente está em Tanner G2P2
- E) Paciente está em Tanner G3P2

### Questão 78

A deficiência de ferro é uma das carências nutricionais mais prevalentes no mundo. Quanto à suplementação profilática do ferro elementar, qual das alternativas abaixo corresponde às recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria:

- A) Prematuros maiores que 1500g e recém-nascidos de baixo peso a partir do 30º dia de vida, recomenda-se 2mg de ferro elementar/kg/dia durante todo o primeiro ano de vida e após este período 1mg/kg/dia até 2 anos de idade.
- B) Prematuros com peso menor que 1000g, a partir do 30º dia de vida, recomenda-se 1mg de ferro elementar/kg/dia durante todo o primeiro ano de vida e após este período 2mg/kg/dia até 2 anos de idade.
- C) Lactentes nascidos a termo, peso adequado, em aleitamento materno exclusivo, recomenda-se 4mg de ferro elementar/kg/dia, a partir do 30º dia de vida e durante todo o primeiro ano de vida. Após 1mg/kg/dia até 2 anos.
- D) Prematuros com peso entre 1000g e 1500g, recomenda-se 1mg/kg/dia de ferro elementar até os 2 anos de idade.
- E) No lactente o ferro elementar só deve ser suplementado em caso documentado de anemia ferropriva.

### Questão 79

A doença diarreica constitui um dos problemas mais graves que afetam a população infantil. Em relação às doenças diarreicas na infância qual das alternativas está INCORRETA?

- A) A diarreia aguda é autolimitada com duração menor que 14 dias.
- B) As cepas de Escherichia coli enterotoxigênicas costumam causar diarreia por mecanismo secretor.
- C) A suplementação de zinco durante o episódio de diarreia aguda reduz a duração e a gravidade do evento diarreico.
- D) Pacientes desnutridos, lactentes jovens e imunodeprimidos são pacientes mais suscetíveis a desenvolver quadros graves de diarreia aguda.
- E) O Vibrio cholerae e a Shigella estão comumente associados à Síndrome Hemolítica Urêmica.

### Questão 80

A icterícia é um dos problemas mais frequentes no período neonatal. Quanto à etiologia da hiperbilirrubinemia indireta no RN, assinale abaixo qual assertiva NÃO corresponde à apresentação de icterícia por hiperbilirrubinemia indireta.

- A) Atresia de Vias Biliares Extra Hepática.
- B) Síndrome da Icterícia por Leite Materno.
- C) Síndrome de Gilbert.
- D) Céfalo-hematoma.
- E) Clampeamento tardio ou ordenha do cordão.

### Questão 81

Adriana, 29 anos, G2 A0 P1, IG = 17s, vem para consulta de pré-natal com seu Médico de Família e Comunidade, trazendo seu cartão de vacina onde se observa três doses de vacina antitetânica aplicadas na gestação anterior há sete anos. Em relação à profilaxia do tétano neonatal, o Médico de Família e Comunidade deve:

- A) Reiniciar o esquema vacinal com três doses, devido ao tempo desde a última vacina;
- B) Orientar a necessidade de dose de reforço;
- C) Orientar que a mesma está imunizada, não sendo necessária dose de reforço;
- D) Aplicar reforço após o parto, a fim de proteger a próxima gestação;
- E) Informar que não há necessidade de saber história vacinal anterior.

### Questão 82

Os quatro elementos estruturais da Atenção Primária à Saúde são:

- A) acesso de primeiro contato, integralidade, longitudinalidade e coordenação do cuidado.
- B) gratuidade, descentralização, municipalização e legalidade.
- C) humanização, referenciamento, contratualização e parcerias público-privadas
- D) competência cultural, sistemas de informação, economia e vacinação
- E) gratuidade, humanização, acesso de primeiro contato e competência cultural.

### Questão 83

Mulher de 48 anos vem para consulta com seu Médico de Família e Comunidade trazendo o resultado de seu exame citopatológico do colo uterino coletado há 2 meses. Resultado: amostra satisfatória; células escamosas endometriais e metaplásicas representadas; células escamosas atípicas de significado indeterminado possivelmente não neoplástica. O exame anterior, realizado há dois anos, era normal. A paciente encontra-se sem queixas. Assinale a alternativa que contém a conduta adequada diante do caso apresentado.

- A) Indicar colposcopia imediatamente para confirmação diagnóstica.
- B) Tratar com antibiótico via oral de amplo espectro.
- C) Tratar com creme vaginal e repetir o CP em 10 dias
- D) Repetir o CP em 6 meses
- E) Encaminhar ao ginecologista para investigação.

### Questão 84

O SUS incorpora o referencial do controle social em seus princípios. Marque a alternativa que corresponde à sua aplicabilidade.

- A) Realização obrigatória de conferências de saúde municipais a cada ano eleitoral.
- B) Realização não obrigatória da reunião dos conselheiros de saúde estaduais.
- C) Somente o conselho nacional de saúde tem composição com garantia de 50% de representantes da população.
- D) Composição dos conselhos estaduais e municipais de saúde com garantia de 50% de representantes da população.
- E) Composição dos conselhos estaduais e municipais com garantia de 50% de representantes dos gestores da Saúde.

**Questão 85**

O instrumento de avaliação familiar que se utiliza de representação gráfica, que identifica todos os sistemas envolvidos e relacionados com a pessoa, com a família e o meio onde vivem é o:

- A) FIRO.
- B) PRACTICE.
- C) Ecomapa.
- D) Genograma.
- E) APGAR Familiar.

**Questão 86**

Contraria os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS):

- A) o direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;
- B) a igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
- C) a divulgação de informações quanto ao potencial de serviços e sua utilização pelo usuário;
- D) a integralidade da assistência estabelecendo duas redes, sendo uma de atenção curativa e outra de atenção preventiva;
- E) a integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.

**Questão 87**

Não é considerado princípio básico ou diretriz do SUS:

- A) Acesso universal e igualitário.
- B) Participação comunitária.
- C) Descentralização.
- D) Rede regionalizada e hierarquizada.
- E) Atendimento compartimentalizado.

**Questão 88**

A implantação de um sistema de referência e contrarreferência entre os serviços que compõem a rede do SUS local busca viabilizar:

- A) a integração com outros setores da economia.
- B) a conjugação de recursos financeiros e tecnológicos.
- C) a preservação da autonomia das pessoas.
- D) a hierarquização da rede de serviços de saúde.
- E) a participação da comunidade.



### Questão 89

Está incorreto:

- A) Não há vantagens do uso do genograma em pacientes com má adesão ao tratamento.
- B) É permitido o uso de cor no genograma.
- C) O genograma por ter um foco biomédico auxilia na contextualização das informações mediante visualização das relações entre o contexto familiar e a doença.
- D) O genograma deve incluir estado marital, casamentos prévios, ocupações.
- E) No genograma os filhos aparecem em ordem cronológica de nascimento, com o mais velho à esquerda.

### Questão 90

Em relação aos atributos da ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, analise as sentenças e numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 1. Primeiro contato. 2. Longitudinalidade. 3. Integralidade. 4. Coordenação. 5. Focalização na família. 6. Orientação comunitária. 7. Competência cultural. ( ) Oferta de aporte regular de cuidados... uso contínuo ao longo do tempo. ( ) Considera a família o sujeito da atenção... ( ) Capacidade de garantir a continuidade da atenção pela equipe. ( ) Reconhecimento das necessidades das famílias... perspectiva populacional. ( ) Relação horizontal entre equipe e população... singularidades culturais. ( ) Acessibilidade e uso de serviços para cada novo problema. ( ) Atender as necessidades da população nos campos da promoção, prevenção, cura, cuidado, reabilitação, palição... Assinale a sequência CORRETA.

- A) 4 - 6 - 2 - 5 - 7 - 1 - 3
- B) 2 - 5 - 4 - 6 - 7 - 1 - 3
- C) 4 - 5 - 2 - 6 - 3 - 1 - 7
- D) 1 - 6 - 3 - 5 - 2 - 4 - 7
- E) 2 - 6 - 4 - 5 - 7 - 1 - 3

### Questão 91

Adolescente de 16 anos solicita à mãe que marque uma consulta médica por estar apresentando cefaleia. No transcorrer da consulta, à qual comparecera desacompanhada, relata ter tido a iniciação de sua atividade sexual há vários meses e que estava interessada em uma orientação sobre anticoncepção. São-lhe fornecidas as explicações cabíveis, prescrito anticoncepcional oral e solicitado retorno. No dia seguinte, a mãe telefona para saber o que a filha havia falado. O médico, avaliando a inexistência de risco à saúde física e emocional da paciente, deve:

- A) dizer para a mãe o real motivo da consulta.
- B) sugerir à mãe uma entrevista pessoal.
- C) ocultar o real motivo da consulta, deixando pistas para que a mãe possa se prevenir contra atos impensados da filha.
- D) informar para a mãe que prometeu à adolescente sigilo sobre as informações por ela solicitadas.
- E) dizer para a mãe que a filha está bem de saúde, não revelando o real motivo da consulta.

**Questão 92**

Em relação à Hanseníase podemos afirmar:

- A) As provas cutâneas, como a reação de Mitsuda, têm grande valor diagnóstico.
- B) O período de incubação é em média de 6 (seis) meses.
- C) Está comprovada a existência de imunidade racial em alguns grupos étnicos isolados.
- D) O homem é o único reservatório de importância demonstrada.
- E) M. Leprae se desenvolve em alguns meios de cultura.

**Questão 93**

O Coeficiente que permite aferir a gravidade de determinada doença é o de:

- A) Prevalência.
- B) Mortalidade.
- C) Incidência.
- D) Letalidade.
- E) Endêmico.

**Questão 94**

O tipo de estudo Epidemiológico que tem a vantagem de produzir medidas diretas de riscos, permitir avaliar a relação entre a exposição a um ou mais fatores de riscos e o surgimento de doença é:

- A) Estudo caso-controle.
- B) Estudo seccional.
- C) Estudo de coorte.
- D) Inquérito epidemiológico.
- E) Ensaio clínico controlado.

**Questão 95**

A Vacina contra sarampo pode ser aplicada, sem qualquer tipo de contraindicação, no caso de:

- A) Gravidez no primeiro trimestre.
- B) Estado de Imunossupressão grave.
- C) Vacinação recente contra a poliomielite.
- D) Uso de imunoglobulina humana nos últimos 30 dias.
- E) Antecedente de reação anafilática após ingestão de ovo de galinha.

**Questão 96**

São fatores de risco para a ocorrência tanto de doença cardiovascular quanto de Diabetes Mellitus:

- A) Herança genética e consumo excessivo de sal.
- B) Ocupações estressantes e baixa escolaridade.
- C) Ocupações menos qualificadas e obesidade.
- D) Hipercolesterolemia e obesidade.
- E) Sedentarismo e obesidade.

### Questão 97

Baseado na Lei Orgânica da Saúde, são princípios organizacionais e doutrinários, exceto:

- A) Regionalização e equidade.
- B) Hierarquização e universalidade.
- C) Descentralização e participação social.
- D) Participação social e integralidade.
- E) Hierarquização e equidade.

### Questão 98

OGP, 19 anos, alt 1,45, 36 kg, G3P0A2, vem à consulta com Bhcg + e usgtv que mostra IG de 8s 5d, BCF 150. PA 120x80, Exames: EAS 10 piócitos, Hgb 10, Hct 39%, glicose 90. Refere tabagismo e etilismo, está feliz com a gestação. Conduta correta:

- A) Iniciar tratamento para ITU com ácido nalidíxico.
- B) Orientação quanto à alimentação, sulfato ferroso 40mg 3 comprimidos dia.
- C) Iniciar sulfato ferroso e ácido fólico.
- D) Referenciar ao pré-Natal de alto risco.
- E) Investigar incompetência istmo cervical e repetir a glicemia.

### Questão 99

Considere os seguintes benefícios da MCP (medicina centrada na pessoa) 1. maior empoderamento do paciente. 2. Maior alívio das preocupações do paciente. 3. Maior taxa de solicitação de testes diagnósticos. 4. Menor taxa de encaminhamentos. 5. Menor custo de tratamento médico. Qual das questões possuem evidência de associação com a maior orientação à pessoa:

- A) Apenas 2, 3, 4 e 5.
- B) Apenas 1, 2, 3, 5.
- C) Apenas 1, 2, 4, 5.
- D) Apenas 1, 3, 4 e 5.
- E) 1, 2, 3, 4, 5.

### Questão 100

A queixa de "pouco leite" ou "leite fraco" deve sempre ser valorizada pois, se não valorizada, pode levar ao desmame precoce. Marque a opção correta. 1. Melhorar o posicionamento e a pega do bebê, quando não adequados. 2. Oferecer as 2 mamas em cada mamada. 3. Diminuir a frequência das mamadas. 4. Trocar de mama várias vezes em uma mamada se a criança estiver sonolenta ou se não sugar vigorosamente. 5. Não ordenhar o leite residual.

- A) V, F, V, F, V.
- B) V, V, F, V, V.
- C) V, V, V, V, F.
- D) V, F, V, F, V.
- E) V, V, F, V, F.